



ODON
CONCURSOS

CORREÇÃO **VARGINHA/AVANÇA SP**



**PROVA CIRURGIÃO DENTISTA – CIRURGIÃO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PREFEITURA
MUNICIPAL DE VARGINHA – MG – AVANÇA SP**

Língua Portuguesa

Questão 1:

Pela última fala da empregada, conclui-se que, para ela:

- (A) Rubem era uma pessoa de pouca fé, por isso seu cajueiro não teria frutos.
- (B) A probabilidade de o cajueiro dar frutos seria maior se Deus ouvisse a fala de Rubem.
- (C) A fala de Rubem era apenas o que faltava para que o cajueiro desse frutos.
- (D) Era impossível que o cajueiro pudesse dar frutos, com ou sem uma intervenção divina.
- (E) O cajueiro daria frutos, a menos que Rubem tivesse fé.

Resposta: B**Comentário:**

A empregada expressa a esperança de que a fala de Rubem possa de alguma forma estimular Deus a agir, de acordo com o sentimento de que Deus estaria "ouvindo" aquilo que ele disse. Com isso, ela está sugerindo que, se o desejo de Rubem for ouvido por Deus, ele poderá se tornar realidade, aumentando assim a chance de o cajueiro, de fato, dar frutos.

Questão 2:

A figura de linguagem presente no trecho “— *Cajueiro sente muito a mudança, morre à toa...*” é a de:

- (A) polissíndeto.
- (B) reticência.
- (C) hipérbole.
- (D) prosopopeia.
- (E) onomatopeia.

Resposta: D**Comentário:**

- (A) Polissíndeto (incorreta): Repetição de conjunções coordenativas (ex: "e fala, e chora, e ri"). Não ocorre no trecho.
- (B) Reticência (incorreta): Uso de "..." para indicar interrupção ou hesitação. Não é a figura principal do trecho, que é a atribuição de um sentido humano à planta.
- (C) Hipérbole (incorreta): Exagero intencional (ex: "morri de rir"). Embora "morre à toa" possa ter um leve exagero, a figura dominante é a humanização da planta.
- (D) Prosopopeia (correta): é a figura de linguagem que atribui características, sentimentos, ações ou qualidades humanas a seres inanimados ou irracionais.
- (E) Onomatopeia (incorreta): Imitação de sons e ruídos (ex: "tic-tac"). Não ocorre no trecho.

Mais detalhes podem ser vistos na nossa aula de Português: Figuras de Linguagem

06) POLISSÍNDETO:

Repetição da conjunção “e”.

E o cachorro latia, e corria, e babava em tudo que via pela frente

2) HIPÉRBOLE:

É o exagero EXTREMO na afirmação.

Ex.: Já lhe disse isso um milhão de vezes.

Quando o filme começou, voei para casa.

II — Figuras de linguagem: PENSAMENTO

1) PROSOPOPEIA/HUMANIZAÇÃO:

Atribuição de qualidades e sentimentos humanos a seres irracionais e inanimados.

A formiga disse para a cigarra: “Cantou...agora dança!”

4. ONOMATOPEIA – Estabelece uma sequência para imitar os sons e ruídos característicos de animais, de objetos quebrando, de fenômenos da natureza.

“Piuí Piuí, Piuí Abacaxi/ Choque choque choque, choque por aí”.

Os sinos fazem blém, blém, blém.

A campainha faz diiin, dommmm.

Questão 3:

Identifique o único excerto a seguir em que o vocábulo “o” é empregado como pronome demonstrativo.

- (A) “Eu fora o culpado, com meu gesto leviano de enterrar a castanha”.
- (B) “Arrancar a plantinha com a minha mão — disso eu não seria capaz; nem mesmo dar ordem para que ela o fizesse.”
- (C) “Ela espera, talvez, que eu o leve para o quintal de algum amigo”.
- (D) “vi que durante a noite aquela coisa verde lançara para o ar um caule com pequenas folhas”.
- (E) “Ela riu muito, depois ficou séria, levou o vaso para a varanda”.

Resposta: B

Comentário:

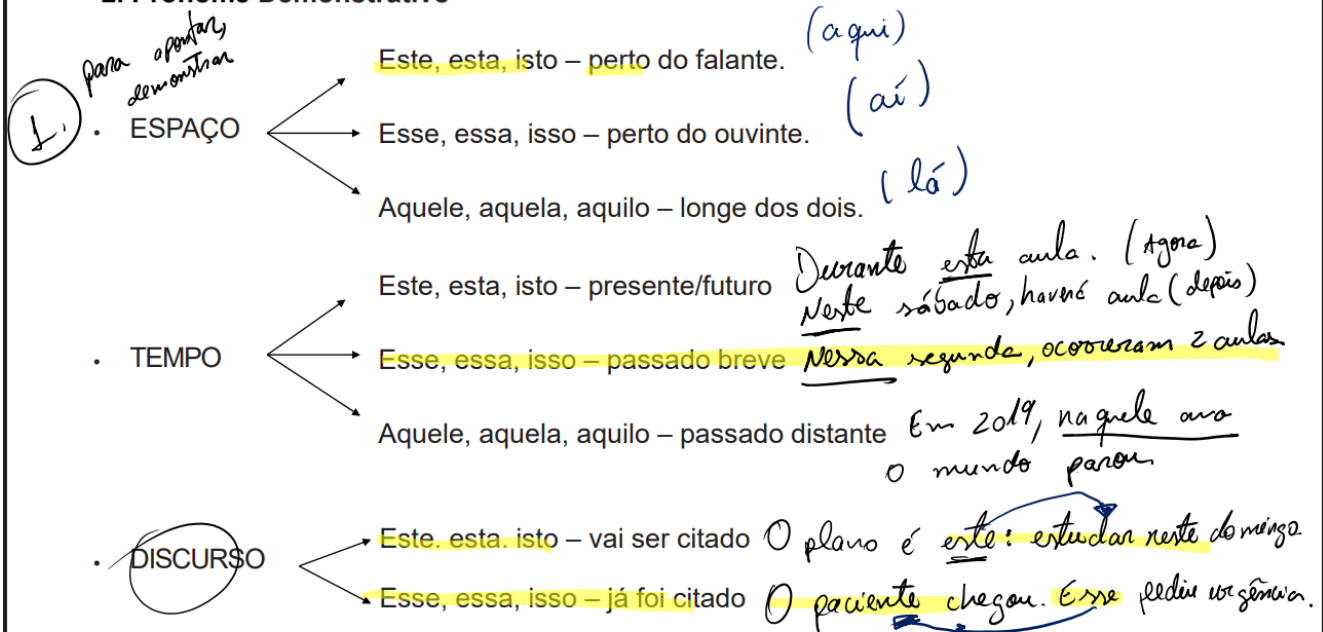
O pronome “o” retoma uma oração ou um fato, tendo valor de pronome demonstrativo (equivalente a isso / aquilo).

Reescrevendo para melhor compreensão:

“...nem mesmo dar ordem para que ela o fizesse.” = “...nem mesmo dar ordem para que ela fizesse isso.”
Dessa forma, em “para que ela o fizesse”, o “o” é pronome demonstrativo, pois retoma a ação anterior (“arrancar a plantinha”) e equivale a “isso”.

Para mais detalhes, ver a nossa aula de Português: Pronomes

2. Pronome Demonstrativo



As formas, **tal (is)**, **o(s)** e **a(s)** podem desempenhar papel de pronome demonstrativo quando têm significado de aquele(a), esse(a). Ex.:

O réu não sabia **o** que responder.

(= ... aquilo que responder.)

Esta rua não é **a** que te indiquei.

(=... aquela que te indiquei.)

Jamais repita **tal** asneira.

(-... essa asneira.)

verbo
preposição
Prefiro **a** de ontem.
(=aquela)

Questão 4:

Os vocábulos “sem” e “sequer”, que ocorrem no trecho “[...] sem sequer me dar conta do que fazia.”, pertencem, respectivamente, às classes gramaticais:

- (A) advérbio e advérbio.
(B) conjunção e substantivo.

- (C) conjunção e advérbio.
(D) preposição e substantivo.
(E) preposição e advérbio.

Resposta: E

Comentário:

- "Sem": É uma palavra invariável que liga o verbo à ideia de ausência ou falta de algo. Essa função é característica da Preposição.
- "Sequer": É uma palavra invariável usada para reforçar uma negação, com o sentido de "pelo menos" ou "nem mesmo". Essa função é característica do Advérbio de negação/reforço.

Embora um advérbio modifique verbos, adjetivos ou outros advérbios, ele pode sim aparecer imediatamente após uma preposição, formando locuções adverbiais. Em português, é comum preposição seguida de advérbio, por exemplo, "sem sequer", "de repente", "com cuidado".

No trecho citado, "sem" é uma preposição que introduz o termo que indica a ausência de algo, e "sequer" é um advérbio que intensifica essa ideia de ausência. Portanto, "sem" não funciona como advérbio, mas como preposição, enquanto "sequer" é advérbio.

No trecho: "sem sequer me dar conta" — A preposição "sem" está regendo a oração reduzida de infinitivo ("me dar conta"), e o advérbio "sequer" está ligado ao verbo dessa oração para intensificar a negação.

Para mais detalhes, ver a nossa aula de Português: Preposição e aula: Advérbio

PREPOSIÇÃO

É uma palavra invariável que liga dois elementos da oração, subordinando o segundo ao primeiro, ou seja, o regente e o regido.

Regência verbal: Assisti **ao** vídeo do curso.

Regência nominal: Estou alheio **a** tudo isso.

Poema **de** amor

ADVÉRBIO (*adjunto adverbial*) = *circunstância*

Advérbio é uma palavra invariável que modifica o sentido do verbo, do adjetivo e do próprio advérbio.

Classificação dos advérbios:

Lugar – ali, aqui, *atrás*, cá, dentro, *no centro*, na loja, na Alemanha, ...

Tempo – *agora*, *amanhã*, *antes*, *ontem*, em 2010, em agosto, neste ano, ...

Modo – a pé, à toa, à vontade, à *disposição*, *tranquilamente*, *rapidamente*, ...

Intensidade – *muito*, pouco, bastante, meio, demasiado, ...

Afirmção – sim, *com certeza*, *certamente*, ...

Negação – *Não*, *nunca*, *jamaiz*, ...

Dúvida – *Talvez*, *quicá*,

FORMAS DO ADVÉRBIO

1. *Palavra única* – *agora*, *lá*, *aqui*, *lá*, *sim*, *não*, *talvez*, ...

2. *locução* (*preposição + substantivo*)
às vezes, *à noite*, *à tarde*, *com certeza*, *à toa*, *à vontade*, ...

3. *Adjetivo + ^{fixo}mente* : *tranquilamente*, *rapidamente*, *calmamente*,
lindamente, *raramente*, *certamente*, ...
tempo *afirmação*

Questão 5:

O verbo em “— *Eu comprei um vaso.*” está conjugado:

- (A) no presente do modo indicativo.
- (B) no pretérito imperfeito do modo indicativo.
- (C) no pretérito perfeito do modo indicativo.
- (D) no pretérito mais-que-perfeito do modo indicativo.
- (E) no pretérito imperfeito do modo subjuntivo.

Resposta: C

Comentário:

O verbo “comprei” é a 1ª pessoa do singular do pretérito perfeito do modo indicativo do verbo “comprar”. Esse tempo verbal expressa uma ação concluída no passado.

Questão 6:

A palavra que tem exatamente o mesmo número de sílabas que “*embaraçada*”, que ocorre no texto, é:

- (A) varanda.
- (B) iniciativa.
- (C) silêncio.
- (D) naturalmente.
- (E) antúrio.

Resposta: D**Comentário:**

A palavra “embaraçada” tem exatamente 5 sílabas: em-ba-ra-ça-da.

Vamos analisar as opções para encontrar aquela que também tem 5 sílabas:

- (A) varanda: va-ran-da (3 sílabas)
- (B) iniciativa: i-ni-ci-a-ti-va (6 sílabas)
- (C) silêncio: si-lên-cio (3 sílabas)
- (D) naturalmente: na-tu-ral-men-te (5 sílabas)
- (E) antúrio: an-tú-rio (3 sílabas)

Questão 7:

Há uma oração introduzida por uma locução concessiva em:

- (A) Sentia falta da amiga, mas não podia se reaproximar.
- (B) Respondeu às enquetes conforme o professor orientou.
- (C) Ela diz que já superou o término da relação, apesar de ainda falar do rapaz.
- (D) Desde que sobre tempo livre para o descanso, você pode ter um segundo ofício.
- (E) As coisas foram se acertando à medida que os dias passavam.

Resposta: C**Comentário:**

A locução concessiva é uma expressão que indica oposição ou concessão, mostrando uma circunstância contrária ao fato principal, mas que não o impede. Exemplos comuns são: “apesar de”, “ainda que”, “embora”, “mesmo que”.

No item (C), “apesar de” introduz a oração concessiva que indica uma oposição à oração principal, mantendo o valor concessivo.

Questão 8:

Identifique em qual das sentenças a seguir ocorre numeral multiplicativo.

- (A) Duas pessoas estavam em sua frente na fila.
- (B) O número de queimadas neste semestre é o triplo do número do semestre passado.
- (C) Nem metade das pessoas convidadas foram ao evento.
- (D) A exposição do museu recebeu um milhão de pessoas nesta semana.
- (E) A carga horária deste trabalho é de apenas vinte horas semanais.

Resposta: B**Comentário:**

Numerais multiplicativos indicam o número de vezes que uma quantidade foi multiplicada, como “dobro”, “triplo”, “quádruplo” etc. Na frase da alternativa (B), o termo “triplo” é um numeral multiplicativo, pois indica que o número de queimadas é três vezes maior que o do semestre passado.

Questão 9:

Análise as sentenças a seguir em relação às expressões em destaque:

- I. Eles não puderam ir à peça de teatro, **porquanto** tiveram de viajar às pressas.
- II. Podemos remarcar a reunião, **caso** você não possa comparecer neste dia.
- III. Ouve música **enquanto** dirige.
- IV. Ele explicou tudo tão detalhadamente, **de sorte que** não restaram dúvidas.

V. Fez o tratamento **consoante** lhe instruíram no hospital.

As expressões destacadas podem ser classificadas quanto ao significado que exprimem, respectivamente, em:

- (A) I. adversativa; II. condicional; III. temporal; IV. consecutiva; V. conformativa.
- (B) I. explicativa; II. conformativa; III. temporal; IV. comparativa; V. conformativa.
- (C) I. causal; II. condicional; III. final; IV. explicativa; V. consecutiva.
- (D) I. causal; II. condicional; III. temporal; IV. consecutiva; V. conformativa.
- (E) I. proporcional; II. concessiva; III. proporcional; IV. explicativa; V. consecutiva.

Resposta: D

Comentário:

I. Porquanto: Significa "porque", "já que". Introduz a causa ou o motivo da ação.

II. Caso: Significa "se". Estabelece a condição para que a ação principal ocorra.

III. Enquanto: Indica que as duas ações ocorrem ao mesmo tempo. Introduz uma ideia temporal.

IV. De sorte que: Significa "de modo que", "portanto". Introduz a consequência ou o resultado do que foi dito na primeira oração.

V. Consoante: Significa "conforme", "de acordo com". Indica a conformidade ou o modo como a ação foi realizada.

Questão 10:

Analise as sentenças a seguir e assinale a alternativa em que há o emprego correto da expressão em destaque.

- (A) Os cabelos mais **cumpridos** serão doados para a confecção de perucas.
- (B) Esses motoristas foram vistos **inflingindo** as leis de trânsito.
- (C) Nunca viu tamanha **discrição** na atitude de dançarinos profissionais.
- (D) A sua ideia **defere** bastante da minha.
- (E) **Apreendeu**-lhe os cigarros, para que deixasse de fumar.

Resposta: C

Comentário:

(A) "cumpridos": O adjetivo correto para indicar extensão, tamanho ou comprimento é compridos.

(B) "inflingindo": O verbo que significa violar, transgredir as leis é infringir.

(C) "discrição": significa a qualidade de ser discreto, reservado, prudente. O uso está correto no contexto de atitude e comportamento.

(D) "defere": O verbo que significa ser diferente, divergir é diferir.

(E) "apreendeu-lhe": Apreendeu-lhe (no sentido de apoderar-se dele/dela) ou Apreendeu os cigarros (confiscou).

Matemática e Raciocínio Lógico

Questão 11:

Um campo de futebol tem 120 m de comprimento e 90 m de largura. Estima-se que um jogador de futebol corra cerca de 12 km por partida. Quantas voltas completas um jogador conseguiria dar ao longo do perímetro do campo percorrendo essa distância?

- (A) 27.
- (B) 28.
- (C) 29.
- (D) 30.
- (E) 31.

Resposta: B

Comentário:

O perímetro do campo de futebol é calculado pela fórmula do perímetro do retângulo:

$$P=2\times(\text{comprimento}+\text{largura})$$

Dado:

Comprimento = 120 m

Largura = 90 m

Calculando o perímetro:

$$P = 2 \times (120 + 90)$$

$$P = 2 \times 210$$

$$P = 420 \text{ metros}$$

Um jogador corre 12 km por partida, que em metros é:

$$12 \text{ km} = 12.000 \text{ metros}$$

Número de voltas completas que o jogador daria ao longo do perímetro:

$$12.000 / 420 = 28,57 \quad 12.000 \approx 28,57$$

Como o jogador só consegue dar voltas completas, ele daria 28 voltas completas.

Questão 12:

Uma professora de química misturou em um recipiente água e óleo numa proporção de 1:3, em volume, resultando num volume total de 12 litros. Em outro recipiente, ela misturou também essas duas substâncias, porém numa proporção de 2:5, resultando num volume total de 14 litros. Se a professora agora misturar o conteúdo dos dois recipientes, qual será a nova proporção entre água e óleo?

(A) 9:16.

(B) 3:16.

(C) 3:8.

(D) 7:19.

(E) 7:15.

Resposta: D

Comentário:

Primeiro recipiente

Proporção água:óleo = 1 : 3

Total de partes = 1 + 3 = 4 partes

Volume total = 12 L

Cada parte = $12/4 = 3\text{L}$

◆ Água = $1 \times 3 = 3\text{L}$

◆ Óleo = $3 \times 3 = 9\text{L}$

Segundo recipiente

Proporção água:óleo = 2 : 5

Total de partes = 2 + 5 = 7 partes

Volume total = 14 L

Cada parte = $14/7 = 2\text{L}$

◆ Água = $2 \times 2 = 4\text{L}$

◆ Óleo = $5 \times 2 = 10\text{L}$

Mistura dos dois recipientes (soma dos volumes)

◆ Água total = $3 + 4 = 7\text{L}$

◆ Óleo total = $9 + 10 = 19\text{L}$

Proporção final:

Água : Óleo = 7 : 19

Questão 13:

Em uma empresa, 40% dos funcionários utilizam carro para ir ao trabalho, 50% utilizam transporte público e 20% utilizam ambos. Se o total de funcionários é de 600 pessoas, quantos não utilizam nem carro nem transporte público para ir ao trabalho?

(A) 140

(B) 120

(C) 160

(D) 100

(E) 180

Resposta: E

Comentário:

Para resolver o problema, devemos usar a fórmula da união de dois conjuntos, considerando a interseção:

- A = funcionários que usam carro = 40% de 600 = 240
- B = funcionários que usam transporte público = 50% de 600 = 300
- Interseção $A \cap B$ = 20% de 600 = 120

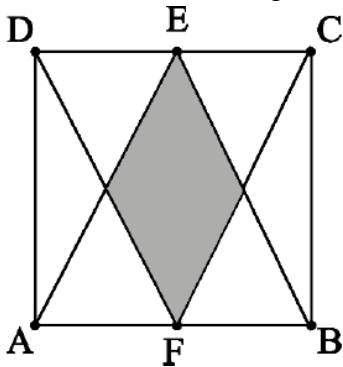
Número de funcionários que usam carro ou transporte público:

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B| = 240 + 300 - 120 = 420$$

Número de funcionários que não usam nem carro nem transporte público:
 $600 - 420 = 180$

Questão 14:

A figura abaixo mostra um quadrado ABCD de lado L e dois triângulos ABE e CDF, onde E e F são os pontos médios dos segmentos CD e AB, respectivamente.



A área de interseção entre os dois triângulos (área sombreada da figura) é dada por:

- (A) $L^2/2$.
- (B) $L^2/4$.
- (C) $L^2/6$.
- (D) $L^2/8$.
- (E) $L^2/16$.

Resposta: B

Comentário:

1. O quadrado ABCD tem lado L .
2. Os pontos E e F são pontos médios dos lados CD e AB, respectivamente. Portanto:
 - E divide CD em dois segmentos de comprimento $L/2$.
 - F divide AB em dois segmentos de comprimento $L/2$.
3. O triângulo ABE tem vértices A, B e E.
 - A base AB tem comprimento L .
 - A altura do triângulo é a distância do ponto E até AB. Como EE está no lado CD, que é paralelo e oposto a AB, e o quadrado tem lado L , a altura é L .
4. O triângulo CDF tem vértices C, D e F.
 - A base CD tem comprimento L .
 - A altura do triângulo é a distância do ponto F até CD, que é também L .
5. A área total do quadrado é L^2 .
6. A área de cada triângulo ABE e CDF é (base X altura dividido por 2)
 - $L \times L / 2 = L^2/2$.
7. A área de interseção sombreada corresponde a um losango dentro do quadrado
 - Para calcular a área do losango, note que: como E e F são pontos médios, o segmento EF tem comprimento igual a $L/2$. A altura do losango é metade de L .
 - Portanto, a área do losango é dada por: (Diagonal maior x diagonal menor)/2
 - área = $(L \times L/2) / 2$
 - **área = $L^2/4$**

Questão 15:

Em um vestibular, a nota de um candidato é calculada com base na média aritmética ponderada entre três disciplinas: português, matemática e redação, cujos pesos são 5, 3 e 2, respectivamente. Dois candidatos, A e B têm a mesma nota na disciplina de português, mas A tem um ponto a mais que B na disciplina de Matemática e B tem um ponto a mais que A na disciplina de redação. Com isso, a diferença entre as notas dos candidatos A e B neste vestibular é:

- (A) 1,0.
- (B) 0,5.
- (C) 0,3.
- (D) 0,2.
- (E) 0,1.

Resposta: E

Comentário:

Disciplinas e pesos:

- Português (P): peso 5
- Matemática (M): peso 3
- Redação (R): peso 2

Médias ponderadas:

$$\text{Nota} = 5P + 3M + 2R / 5 + 3 + 2$$

$$\text{Nota} = 5P + 3M + 2R / 10$$

Condições entre candidatos A e B:

- $PA = PB$
- $MA = MB + 1$
- $RB = RA + 1$ (ou seja, $RA = RB - 1$)

O que a questão pede: diferença entre as notas (lembrando que a nota é a média ponderada)

- $\text{NotaA} - \text{NotaB} = (5PA + 3MA + 2RA / 10) - (5PB + 3MB + 2RB / 10)$
- Como $PA = PB$, já podemos cortar do cálculo, ficando:
 $(3MA + 2RA) - (3MB + 2RB) / 10$
- Reorganizando o cálculo, temos:
 $3(MA - MB) + 2(RA - RB) / 10$
- Lembrando que:
 - $MA - MB = 1$
 - $RA - RB = -1$
- Agora podemos finalizar:
 $\text{Nota A} - \text{Nota B} = 3(1) + 2(-1) / 10$
 $\text{NotaA} - \text{NotaB} = 3 - 2 / 10$
 $\text{NotaA} - \text{NotaB} = 1 / 10$
NotaA - NotaB = 0,1

Questão 16:

Observe a seguinte sequência lógica numérica:

2, 6, 12, 20, 30, ...

O próximo elemento dessa sequência será:

- (A) 36.
- (B) 60.
- (C) 52.
- (D) 42.
- (E) 46.

Resposta: D

Comentário:

A sequência dada é: 2, 6, 12, 20, 30, ...

Analisando as diferenças entre os termos consecutivos:

$$6 - 2 = 4$$

$$12 - 6 = 6$$

$$20 - 12 = 8$$

$$30 - 20 = 10$$

A diferença entre os termos está aumentando de 2 em 2 (4, 6, 8, 10,...).

Assim, o próximo termo será:

$$30 + 12 = 42$$

Questão 17:

Uma costureira fabrica camisas para vender. Ela sabe que seu custo de produção por camisa é de R\$ 80,00. O preço de venda das camisas é constituído pelo custo de produção mais o lucro. Além disso, sabe-se que o lucro corresponde a 60% do valor da venda. Nesta situação, qual o lucro da costureira por camisa?

- (A) R\$ 90.
- (B) R\$ 48.
- (C) R\$ 160.
- (D) R\$ 128.
- (E) R\$ 120.

Resposta: E**Comentário:**

O lucro corresponde a 60% do preço de venda (PV), ou seja:

- $\text{Lucro} = 0,6 \times \text{PV}$

Sabemos que o preço de venda (PV) é a soma do custo (C) e do lucro:

- $\text{PV} = \text{C} + \text{Lucro}$
 $\text{PV} = 80 + \text{Lucro}$

Substituindo o Lucro:

- $\text{PV} = 80 + 0,6 \times \text{PV}$
 $\text{PV} - 0,6 \times \text{PV} = 80$
 $0,4 \times \text{PV} = 80$
 $\text{PV} = 80 / 0,4$
 $\text{PV} = 200$

Agora calculamos o lucro:

- $\text{Lucro} = 0,6 \times 200$
Lucro = 120

Questão 18:

Numa fábrica, dois alarmes soam periodicamente. Um deles a cada 12 minutos e o outro a cada 18 minutos. Em certo instante, os alarmes soaram simultaneamente. Em quanto tempo após este instante eles soarão simultaneamente novamente pela primeira vez?

- (A) 30 minutos.
- (B) 36 minutos.
- (C) 54 minutos.
- (D) 120 minutos.
- (E) 180 minutos.

Resposta: B**Comentário:**

Os alarmes soam simultaneamente no instante inicial, e o próximo momento em que soarão juntos novamente será após o mínimo múltiplo comum (MMC) dos períodos 12 e 18 minutos.

Cálculo do MMC de 12 e 18:

- Fatores primos de 12: $2^2 \times 3^2$
- Fatores primos de 18: 2×3^2

MMC é o produto dos maiores expoentes dos fatores primos:

- $\text{MMC} = 2^2 \times 3^2 = 4 \times 9 = 36$

Logo, os alarmes soarão juntos novamente após 36 minutos.

Questão 19:

Em um torneio de xadrez com 50 jogadores, 40% são mestres e o restante são iniciantes. Quantos jogadores são iniciantes?

- (A) 15
- (B) 20
- (C) 25
- (D) 30
- (E) 35

Resposta: D**Comentário:**

O total de jogadores representa 100%. Se 40% são mestres, o restante (100% - 40%) são iniciantes. Assim: Porcentagem de Iniciantes = 100% - 40% = 60%

O número total de jogadores é 50. O número de iniciantes corresponde a 60% desse total.

Número de Iniciantes = 60% de 50

Número de Iniciantes = $0,6 \times 50$

Número de Iniciantes = 30

Questão 20:

João produz 80 kg de morangos por dia para fazer geleia. Para cada 5 kg de morango, ele produz 2 litros de geleia. A geleia é colocada em potes de 500 ml, que são embalados em caixas contendo 8 potes cada. Cada caixa é vendida por R\$ 64,00. Quanto João arrecada por dia com a venda da geleia?

- (A) R\$ 620,00
- (B) R\$ 1.280,00
- (C) R\$ 640,00
- (D) R\$ 800,00
- (E) R\$ 512,00

Resposta: E**Comentário:**

Para calcular a arrecadação diária da costureira com a venda da geleia:

- Produz 80 kg de morangos por dia.
- Para cada 5 kg de morango produz 2 litros de geleia.
- Volume total de geleia produzida:
 $80\text{kg}/5\text{kg} \times 2\text{L} =$
 $16 \times 2 = 32 \text{ litros}$
- Cada pote tem 500 ml = 0,5 litro.
Número de potes:
 $32\text{L} / 0,5\text{L por pote} = 64 \text{ potes}$
- Cada caixa contém 8 potes.
Número de caixas:
 $64 \text{ potes} / 8 \text{ potes por caixa} = 8 \text{ caixas}$
- Cada caixa é vendida por R\$ 64,00.
Total arrecadado por dia:
 $8 \times 64 = \mathbf{512 \text{ reais}}$

Noções de Informática

Questão 21:

Qual é o nome da ferramenta do Windows que possibilita que o usuário ajuste as configurações do computador, como relógio e região, aparência e personalização?

- (A) Gerenciador de rede.
- (B) Gerenciador de usuário.
- (C) Painel de controle.
- (D) Painel de restrições.

(E) Painel de segurança.

Resposta: C

Comentário:

A ferramenta do Windows que possibilita ao usuário ajustar as configurações do computador, como relógio e região, aparência e personalização, é o Painel de Controle.

Questão 22:

Analise a imagem a seguir, que relaciona os principais campos do explorador de arquivos do sistema operacional Windows e assinale a alternativa que descreve o nome do componente destacado:



- (A) Caixa de pesquisa.
- (B) Botão de ordem ascendente.
- (C) Botão de ordem decrescente.
- (D) Painel de detalhes.
- (E) Botão de exclusão.

Resposta: A

Comentário:

O componente destacado na imagem é a caixa de pesquisa do Explorador de Arquivos do Windows, usada para localizar arquivos e pastas dentro do diretório atual.

Questão 23:

Indique a alternativa que apresenta o atalho de teclado do Windows que realiza a exclusão de um arquivo ou pasta, sem enviá-lo para a Lixeira:

- (A) Shift + Delete.
- (B) Enter + Delete.
- (C) Ctrl + Delete.
- (D) Shift + End.
- (E) Shift + 0.

Resposta: A

Comentário:

O atalho de teclado do Windows que realiza a exclusão imediata de um arquivo ou pasta, sem enviá-lo para a Lixeira, é: Shift + Delete.

Questão 24:

Os navegadores de internet, também conhecidos como browsers, são programas utilizados para acessar e visualizar páginas na web. Qual dos aplicativos mencionados abaixo foi criado pela Microsoft para navegação na internet?

- (A) Mozilla.
- (B) Google Chrome.
- (C) Microsoft Edge.
- (D) C#.
- (E) Java.

Resposta: C

Comentário:

O aplicativo criado pela Microsoft especificamente para navegação na internet, e que substituiu o antigo Internet Explorer, é o Microsoft Edge.

- (A) Mozilla: Refere-se à fundação por trás do navegador Firefox.
- (B) Google Chrome: Navegador desenvolvido pelo Google.
- (C) Microsoft Edge: Navegador desenvolvido pela Microsoft.
- (D) C#: Linguagem de programação da Microsoft.
- (E) Java: Linguagem de programação (atualmente propriedade da Oracle).

Questão 25:

Considerando as funcionalidades presentes no programa Microsoft Word, o botão ilustrado na imagem a seguir, que pode ser acessado por meio da guia Design, no grupo Plano de Fundo da Página, está associado à opção:



- (A) Inserir legenda.
- (B) Inserir gráfico.
- (C) Inserir tabela.
- (D) Marca-d'água.
- (E) Bordas de página.

Resposta: D

Comentário:

O ícone mostrado na imagem corresponde à ferramenta de Marca-d'água no Microsoft Word.

Conhecimentos Específicos

Questão 26:

A Saúde da Família é uma estratégia proposta para a reorganização dos serviços de saúde na Atenção Primária. Ela propõe o processo de trabalho inserido no contexto do Sistema Único de Saúde (SUS) e centrado na vigilância em saúde através de ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde. Considerando os cuidados com a saúde bucal de bebês, é correto afirmar sobre as cáries de mamadeira (também chamadas de cáries de aparecimento precoce):

- (A) Iniciam-se preferencialmente nos dentes inferiores posteriores e costumam evoluir de forma lenta e localizada.
- (B) São causadas exclusivamente pela oferta de alimentos sólidos com alto teor de açúcar durante o período diurno.
- (C) Aparecem devido à permanência prolongada do leite na região inferior posterior dos dentes do bebê e depois escoam para a região anterior, causando as cáries rampantes.
- (D) Estão associadas exclusivamente ao uso de chupetas e mordedores, sendo raras em bebês que ainda não iniciaram a alimentação complementar.
- (E) Aparecem devido ao leite depositado a noite inteira na região superior anterior dos dentes do bebê, que depois escoam para a região posterior, causando as cáries rampantes.

Resposta: E

Comentário:

- (A) Errado. As cáries de mamadeira iniciam-se preferencialmente na região superior anterior dos dentes, não nos inferiores posteriores, e evoluem rapidamente (cáries rampantes).
- (B) Errado. A cárie de mamadeira está ligada principalmente à permanência prolongada de líquidos açucarados (leite, fórmulas) na boca, especialmente à noite, não apenas alimentos sólidos durante o dia.
- (C) Errado. A localização primária é a região superior anterior, e não a inferior posterior.
- (D) Errado. Embora chupetas possam ser um fator, a principal causa é a permanência do leite e seu açúcar na boca por longos períodos, mesmo sem alimentação complementar.
- (E) Correto. Essa alternativa está de acordo com a literatura, pois as cáries de mamadeira iniciam na região superior anterior devido à exposição prolongada do leite durante a noite, causando cáries rápidas e extensas.

Mais detalhes podem ser vistos na nossa aula “Saúde na Escola” de Odontologia em Saúde Coletiva:

Com relação à idade de 5 anos, com presença majoritária de dentes decíduos, o inquérito SB Brasil 2010 encontrou a média de ceod foi 2,4 dentes afetados por cárie/perdidos e obturados nessa faixa etária, sendo a maioria deles (80%) formada por dentes ainda não tratados (cariados). Esse dado é de extrema relevância aos gestores, aos profissionais de saúde e aos pais/responsáveis, pois a cárie precoce de infância é uma condição evitável por meio da promoção de hábitos saudáveis, como o não consumo de alimentos com adição de açúcar e/ou

ultraprocessados e o incentivo à escovação dentária a partir da erupção (“nascimento”) dos dentes na boca – especialmente a escovação noturna antes da criança dormir.

Hábitos alimentares e comportamentais

Os hábitos alimentares saudáveis são fundamentais em todas as etapas da vida. A infância e a adolescência são momentos da vida em que os hábitos dos indivíduos são formados e modificados, sendo essencial estimular alimentação adequada e saudável, que contribui para a diminuição de agravos sistêmicos e bucais.

As doenças bucais mais prevalentes – cárie e doença periodontal – estão intimamente ligadas aos hábitos de vida dos indivíduos.

Nesse sentido, é importante destacar que a ação do PSE de Alimentação Saudável e Prevenção da Obesidade se integra à ação de saúde bucal, pois o consumo precoce de alimentos açucarados e/ou ultraprocessados podem causar o desenvolvimento de cárie precoce de infância.

Questão 27:

O Espaço Geográfico contínuo formado por agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais, além de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhadas, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde, é denominado:

- (A) Polo Integrado de Saúde.
- (B) Região Metropolitana de Saúde.
- (C) Região de Saúde.
- (D) Área Territorial de Gestão Sanitária.
- (E) Complexo Intermunicipal de Saúde.

Resposta: C

Comentário:

De acordo com o Decreto nº 7.508/2011, que regulamenta a Lei Orgânica da Saúde (Lei nº 8.080/1990):

Região de Saúde é o espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais, bem como de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhadas, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução das ações e serviços de saúde.

Podemos ver mais detalhes na aula de SUS: Decreto 7508 de 28 de Junho de 2011

➤ Art. 2º Para efeito deste Decreto, considera-se:

- Região de Saúde - **espaço geográfico contínuo** constituído por agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde;

Questão 28:

A cárie dentária é definida como uma doença em que a atividade metabólica das bactérias resulta em um contínuo processo de desmineralização e remineralização do tecido dentário, tal desequilíbrio pode causar uma progressão da desmineralização do dente com consequente formação da lesão de cárie. Considerando os conhecimentos sobre a cárie dentária, analise os itens abaixo e assinale a alternativa correta.

I – A cárie é uma doença infecciosa, transmissível, açúcar-dependente e de caráter bio-social. A lesão de cárie inativa em esmalte é caracterizada por uma mancha branca opaca, rugosa e porosa, podendo ser inativada com higiene bucal adequada e uso de produtos fluoretados.

II – A cárie dentária é determinada por fatores hormonais e genéticos, sendo a ingestão de açúcares irrelevante para seu desenvolvimento, e sua reversão só é possível por meio de tratamento cirúrgico restaurador, pois o uso de flúor e a remoção do biofilme dentário não apresentam eficácia no controle da doença.

(A) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.

(B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é um complemento da I.

(C) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.

(D) As asserções I e II são proposições falsas.

(E) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é um complemento da I.

Resposta: D**Comentário:**

I. A lesão de cárie inativa não é rugosa e porosa, e sim lisa e brilhante, pois não está mais ativa. As lesões ativas é que são opacas, rugosas e porosas.

II. A cárie não é determinada por fatores hormonais/genéticos; os açúcares são fundamentais no processo da doença; o uso de flúor e a remoção do biofilme dentário apresentam sim eficácia no controle da doença.

Mais detalhes podem ser vistos na nossa aula de Dentística: Cariologia e Flúor

HOSPEDEIRO:

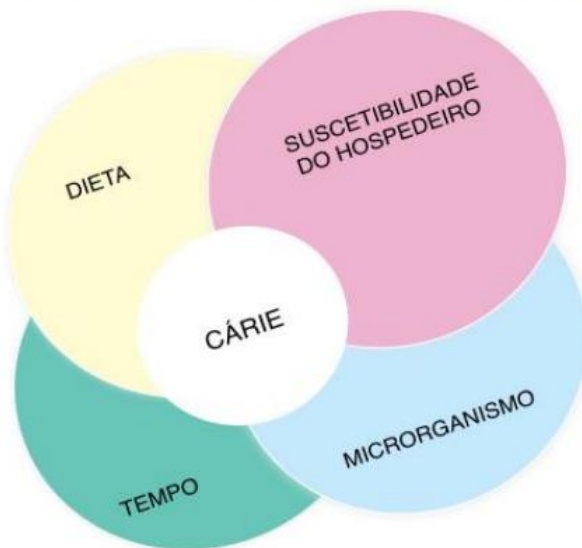
Dente (pobre higienização e falta de fluorterapia).

Observação 5! Locais que favorecem acúmulo do biofilme, são os que tem maior incidência de cárie. Em ordem – **oclusal > área cervical do contato proximal (abaixo do ponto de contato) > margem gengival.**

SUBSTRATO/DIETA:

Qualquer carboidrato (sendo o mais cariogênico a sacarose) pode produzir ácido lático e diminuir o pH do meio. Tudo vai depender da frequência que o carboidrato é consumido e também da consistência do alimento. **Quanto mais pegajoso, mais cariogênico.**

Sem um desses pilares, não tem lesão! E TUDO DEPENDE DO TEMPO. (Tríade de Keyes + tempo)



Lesão inativa sem cavitação: “Lesão de mancha branca inativa”. **Mancha branca ou castanha e superfície brilhante e lisa.**

**Questão 29:**

Na prática clínica, existe um método radiográfico amplamente utilizado para a detecção de cáries, especialmente nas superfícies proximais, com alta eficácia na avaliação da profundidade das lesões. Qual é o nome desse exame?

- (A) Radiografia bitewing (interproximal).
- (B) Radiografia panorâmica.
- (C) Radiografia oclusal.
- (D) Radiografia periapical.
- (E) Tomografia computadorizada.

Resposta: A

Comentário:

A radiografia bitewing (interproximal) é uma técnica intraoral que permite visualizar as coroas dos dentes superiores e inferiores numa única imagem. Ela é especialmente eficaz para detectar cáries em superfícies proximais, que são difíceis de diagnosticar clinicamente. Além disso, possibilita avaliar a profundidade das lesões cariosas e o estado da crista óssea ao redor dos dentes.

Outros exames:

- Radiografia panorâmica: fornece uma visão geral da arcada dentária e estruturas adjacentes, mas com menor detalhamento para lesões iniciais.
- Radiografia oclusal: avalia áreas maiores da boca, usada mais para detectar corpos estranhos ou fraturas.
- Radiografia periapical: foca no dente individual, útil para avaliar a raiz e tecidos periapicais, menos indicada para cáries proximais.
- Tomografia computadorizada: exame avançado usado para avaliação tridimensional, não é rotina para diagnóstico de cáries.

Mais detalhes podem ser vistos na aula de Radiologia: Radiografias extrabucais

Radiografia Panorâmica

A radiografia panorâmica é uma radiografia de técnica extra-bucal e possibilita o **exame de ambos os arcos dentários em apenas uma incidência** radiográfica. É um exame que tecnicamente não é complexo e a dose de radiação recebida é pequena. Este tipo de radiografia deve detectar precocemente problemas de erupção e desenvolvimento, para que possa reduzir a necessidade de um tratamento ortodôntico prolongado.

Esta tomada radiográfica também auxilia no diagnóstico e acompanhamento em **ortodontia e odontopediatria**, sendo de grande valor no **controle pós-trauma ósseo**, especialmente nos casos que o paciente apresenta trismo ou imobilizações maxilo-mandibulares.

A tomografia computadorizada de feixe cônico (TCFC) ou Tomografia computadorizada Cone Beam:

A técnica *cone beam (uso odontológico)* faz uma varredura, com uma única rotação de uma fonte de raios-X. Um pistão sensor de raios-X, fixo por um braço, gira em torno da cabeça do paciente de forma a adquirir muitas projeções simples ou base de imagens. Ou seja: em uma exposição única com o uso de um **feixe em forma de cone**, rotacionando em 360 graus, obtém-se uma imagem tridimensional do paciente na tela do computador, imagem que pode ser trabalhada, segmentada e analisada em qualquer plano ou incidência.

Permite enxergar todas as estruturas em camadas, principalmente os tecidos mineralizados (porém não apenas)

Vantagens:

- Sofisticação tecnológica, em que a velocidade da totalidade do corte é controlada através de um programa eletrônico e não, por velocidade do tubo de raios-X;
- Mesmas condições de tempo de escaneamento, através de uma simples aquisição
- Imagem tridimensional

Importante!

A tomografia possui maior radiação do que as radiografias convencionais de uso odontológico.

Também podemos ver na aula de Radiologia: Técnicas Radiográficas Intraorais

Técnica Periapical

- As radiografias periapicais devem mostrar todo o dente, inclusive o osso alveolar circunjacente. Duas técnicas intraorais são comumente utilizadas para obtenção das imagens periapicais: técnica do paralelismo e técnica da bisettriz

Indicações

- Estudo da relação decíduo-permanente;
- Visualização da forma da câmara pulpar
- Visualização da forma, tamanho e número de raízes;
- Visualização de lesões periapicais;
- Visualização de reabsorção dental;
- Visualização de nódulos pulpares;
- Visualização de dentes inclusos;
- Presença de pequenas alterações coronárias;

Técnica Interproximal ou Bitewing

As imagens bitewings incluem as coroas dos dentes superiores e inferiores e a crista alveolar adjacente em um mesmo receptor de imagem.

O feixe de raios x alinhado através dos pontos de contato e paralelo ao plano oclusal (cilindrolocalizador a +10 graus evitando, assim, a sobreposição das cúspides nas superfícies oclusais)

Paciente com perda óssea moderada ou grave, pode-se realizar a radiografia interproximal com ofilme orientado na posição vertical.

- Visualização de cáries;
- Avaliação periodontal;
- Visualização da adaptação marginal de restaurações

Técnica Oclusal

As imagens oclusais mostram uma área ampla dos dentes e osso alveolar, sendo bastante úteis, também, para pacientes com abertura bucal limitada.

Indicações

- Pesquisa de raízes residuais em edêntulos;
- Pesquisa de dentes inclusos;
- Pesquisa de dentes supranumerários;
- Estudo de grandes áreas patológicas;
- Estudo de fratura dos maxilares;
- Pesquisa de corpos estranhos e cálculos nos ductos das glândulas sublinguais e submandibulares;
- Estudo da integridade do contorno do seio maxilar;
- Ajudar no exame de pacientes com trismo;
- Estudo de fendas palatinas.

Questão 30:

A raspagem e alisamento radicular (RAR) é um procedimento fundamental na terapia periodontal, com objetivos claros relacionados à remoção de fatores etiológicos locais e ao restabelecimento da integridade dos tecidos periodontais. Analise as alternativas abaixo e assinale a correta sobre a RAR:

(A) A raspagem e alisamento radicular têm como finalidade exclusiva a remoção de tecido gengival inflamado, sendo indicada apenas em casos de gengivite ulcerativa necrosante, sem participação ativa do paciente nos cuidados domiciliares.

(B) O objetivo principal da RAR é a remoção de resíduos alimentares e pigmentações extrínsecas, sendo um procedimento estético complementar que não interfere diretamente na integridade dos tecidos periodontais nem no controle do biofilme bacteriano.

(C) A RAR consiste em um procedimento cirúrgico invasivo que utiliza substâncias químicas para dissolução do tártaro subgengival, sendo contraindicado em pacientes que realizam higiene bucal diária com escova e fio dental.

(D) A raspagem e alisamento radicular (RAR) é o procedimento que visa à remoção de placa e cálculo supra e subgengivais e obtenção de uma superfície lisa e dura. A raspagem é a remoção de placa e cálculo, enquanto o alisamento é a remoção de cemento amolecido para tornar a superfície lisa e dura.

(E) A RAR é considerada uma técnica obsoleta, substituída por métodos farmacológicos modernos, como o uso de antibióticos tópicos, não sendo mais indicada como estratégia de controle do biofilme bacteriano.

Resposta: D**Comentário:**

(A) Incorreta – A RAR não tem como finalidade exclusiva a remoção do tecido gengival inflamado, mas sim a remoção de placa bacteriana e cálculo dental supra e subgengival para controlar a infecção periodontal. Além disso, é indicada em casos de periodontite, não apenas em gengivite ulcerativa necrosante, e o paciente deve participar ativamente dos cuidados domiciliares.

(B) Incorreta – A RAR não tem objetivo estético e não é um procedimento para remover resíduos alimentares ou pigmentações extrínsecas. Seu foco é a remoção de cálculo e placa bacteriana para controlar a inflamação dos tecidos periodontais.

(C) Incorreta – A RAR não é um procedimento cirúrgico nem utiliza substâncias químicas para dissolução do tártaro. É um procedimento mecânico realizado com instrumentos manuais ou ultrassônicos e é indicado justamente para pacientes que apresentam biofilme e cálculo, independentemente dos cuidados diários.

(D) Correta – Descreve precisamente o procedimento: raspagem é a remoção de placa e cálculo, e alisamento é a remoção do cemento radicular amolecido para deixar a superfície radicular lisa e dura, dificultando a recolocação do biofilme bacteriano.

(E) Incorreta – A RAR não é técnica obsoleta, continua sendo a base do tratamento periodontal, complementada eventualmente por medidas farmacológicas, mas não substituída por elas.

Mais detalhes podem ser vistos na aula de Periodontia: Terapia não-cirúrgica

Terapia não-Cirúrgica: Raspagem Supragengival e RAR

- A remoção dos depósitos microbianos atua na resolução da inflamação gengival
 - **cálculo supragengival** → menos calcificado e retentivo
 - **cálculo subgengival** → mais retentivo e endurecido
- Com a inflamação sob controle, cessa a destruição dos tecidos de suporte periodontais
- A superfície radicular fica propensa à formação de nova inserção periodontal
- Instrumentos comumente utilizados → curetas e ultrassons



O cálculo age como fator retentor de biofilme, sendo, dessa forma, um agente etiológico secundário das doenças periodontais e que precisa ser removido.

Questão 31:

No contexto da organização dos serviços de saúde no Sistema Único de Saúde (SUS), a Atenção Primária à Saúde constitui o primeiro nível de atenção, sendo responsável pelo cuidado básico à população. Analise as alternativas abaixo e assinale a correta sobre a atuação da equipe de Saúde Bucal nesse nível de atenção:

- (A) A equipe de Saúde Bucal é responsável pelo cuidado contínuo e atua na Atenção Primária à Saúde. Esses profissionais são responsáveis por realizar ações de promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde.
- (B) O atendimento da equipe de Saúde Bucal se limita ao controle de urgências odontológicas e encaminhamentos para unidades de média e alta complexidade.
- (C) A equipe de Saúde Bucal desenvolve ações exclusivamente clínicas, sem vínculo com as unidades da Estratégia Saúde da Família.
- (D) A equipe de Saúde Bucal atua de forma eventual, prestando atendimento apenas em campanhas específicas previamente autorizadas pelos gestores locais de saúde pública.
- (E) As ações desenvolvidas pelas equipes de Saúde Bucal na Atenção Primária têm caráter exclusivamente educativo, sem envolvimento com diagnóstico, tratamento ou reabilitação odontológica.

Resposta: A

Comentário:

- (A) Correto. O escopo da eSB na APS, especialmente na Estratégia Saúde da Família (eSF), abrange a integralidade do cuidado: desde a promoção e prevenção (ações coletivas), até o diagnóstico, tratamento e reabilitação (ações clínicas), garantindo a continuidade do cuidado.
- (B) Incorreto. A APS é a porta de entrada e deve resolver a maior parte dos problemas de saúde (resolutividade), não se limitando a urgências e encaminhamentos.
- (C) Incorreto. As eSBs devem desenvolver ações clínicas e coletivas e estão fortemente integradas, sendo a maioria vinculada às equipes da Estratégia Saúde da Família (eSF).
- (D) Incorreto. A atuação da eSB na APS é contínua e programada, e não eventual.
- (E) Incorreto. As ações são educativas e clínicas. O tratamento e a reabilitação básica são essenciais para a resolutividade na APS.

Mais detalhes podem ser vistos na aula de Saúde Coletiva: Política nacional de saúde bucal/programa Brasil sorridente

POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL/PROGRAMA BRASIL Sorridente

Durante anos, a Odontologia esteve à margem das políticas públicas de saúde. O acesso dos brasileiros à saúde bucal era extremamente difícil e limitado. Esta demora na procura ao atendimento aliada aos poucos serviços odontológicos oferecidos faziam com que o principal tratamento oferecido pela rede pública fosse a extração dentária, perpetuando a visão da odontologia mutiladora e do cirurgião-dentista com atuação apenas clínica.

Para mudar esse quadro, a PNSB foi criada, e o instrumento que ela utiliza para pôr em prática todas as funções, direitos e deveres é o **Programa Brasil Sorridente – PBS, ambos criados em 2003 e instituídos/lançados em 2004** com Humberto Costa como Ministro da Saúde.

O Brasil Sorridente constitui-se em uma série de medidas que visam a **garantir ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde bucal dos brasileiros**, fundamental para a saúde geral e qualidade de vida da população.

Seu principal objetivo é a **reorganização da prática e a qualificação das ações e serviços oferecidos**, reunindo uma série de ações em saúde bucal voltada para os cidadãos de todas as idades, com **ampliação do acesso** ao tratamento odontológico gratuito aos brasileiros por meio do Sistema Único de Saúde (SUS).

Integralidade da atenção: A equipe deve estar capacitada a oferecer de forma conjunta ações de **promoção, proteção, prevenção, tratamento, cura e reabilitação**, tanto no nível individual quanto coletivo.

Questão 32:

No contexto Constitucional Brasileiro, a ordem social possui fundamentos e objetivos próprios, sendo que o Estado exerce papel essencial na condução das políticas sociais. Neste sentido, é correto afirmar que a ordem social tem como base e objetivo, respectivamente:

- (A) A livre iniciativa e a igualdade social e política.
- (B) A soberania nacional e o pluralismo político.
- (C) O primado do trabalho e o bem-estar e a justiça sociais.
- (D) A eficiência administrativa e a competitividade econômica.
- (E) A liberdade coletiva e a segurança privada.

Resposta: C

Comentário:

A ordem social, conforme está definida na Constituição Federal Brasileira de 1988 (Art. 193), tem como base o primado do trabalho e objetivo: o bem-estar e a justiça sociais

Essa configuração está prevista no Título VIII - Da Ordem Social, destacando o papel do trabalho como fundamento e o bem-estar e justiça sociais como metas da ordem social no Brasil.

Questão 33:

Entre as atribuições dos profissionais da Atenção Básica, há atribuições comuns a todos os membros das equipes que atuam nesse nível de atenção, bem como atribuições específicas dos profissionais que compõem essas equipes.

Das alternativas abaixo, assinale aquela que corresponde a uma atribuição específica do cirurgião-dentista.

- (A) Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos e vulnerabilidades.
- (B) Realizar ações de atenção à saúde conforme a necessidade de saúde da população local, bem como aquelas previstas nas prioridades, protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas, assim como, na oferta nacional de ações e serviços essenciais e ampliados da AB.
- (C) Responsabilizar-se pelo acompanhamento da população adscrita ao longo do tempo no que se refere às múltiplas situações de doenças e agravos, e às necessidades de cuidados preventivos,

permitindo a longitudinalidade do cuidado.

(D) Utilizar o Sistema de Informação da Atenção Básica vigente para registro das ações de saúde na AB, visando subsidiar gestão, planejamento, investigação clínica e epidemiológica, e à avaliação dos serviços de saúde.

(E) Coordenar e participar de ações coletivas voltadas à promoção da saúde e à prevenção de doenças bucais.

Resposta: E

Comentário:

Coordenar e participar de ações coletivas voltadas à promoção da saúde e à prevenção de doenças bucais é uma atribuição específica do Cirurgião-Dentista (e da Equipe de Saúde Bucal, em geral). Embora todos participem de ações de promoção à saúde, a coordenação e a especificidade das ações voltadas às doenças bucais (como escovação supervisionada com flúor, palestras sobre dieta e cárie) são responsabilidade primária do cirurgião-dentista na atenção básica.

As demais alternativas se referem a atribuições que são de responsabilidade de toda a equipe de saúde, não só dos dentistas.

Mais detalhes podem ser vistos na nossa aula de SUS e Saúde Pública: PNAB 2017

Atribuições do Cirurgião-dentista na Atenção Básica

- ☐ Realizar a atenção em saúde bucal individual e coletiva a todas as famílias, a indivíduos e a grupos específicos, atividades em grupo na UBS e, quando indicado ou necessário em outros espaços;
- ☐ Realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil epidemiológico para o planejamento e a programação em saúde bucal no território;
- ☐ Realizar os procedimentos clínicos e cirúrgicos da AB em saúde bucal, incluindo:

- ✓ procedimentos relacionados com as fases clínicas de moldagem, adaptação e acompanhamento de próteses dentárias (elementar, total e parcial removível);
- ✓ atendimento das urgências;
- ✓ pequenas cirurgias ambulatoriais.

- ☐ Coordenar e participar de ações coletivas voltadas à promoção da saúde e à prevenção de doenças bucais;
- ☐ Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde com os demais membros da equipe, buscando aproximar saúde bucal e integrar ações de forma multidisciplinar;
- ☐ Realizar supervisão do técnico em saúde bucal (TSB) e auxiliar em saúde bucal (ASB);
- ☐ Planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos ACS e ACE em conjunto com os outros membros da equipe;
- ☐ Realizar estratificação de risco e elaborar plano de cuidados para as pessoas que possuem condições crônicas no território, junto aos demais membros da equipe;
- ☐ Exercer outras atribuições que sejam de responsabilidade na sua área de atuação.

Questão 34:

Efeito colateral sistêmico da ingestão de flúor presente na água em concentração recomendada para prevenção da cárie dentária em nível populacional e que está relacionado ao período de formação dos dentes e pode ocorrer também pelo uso combinado de diferentes fontes de fluoreto, é denominado:

- (A) Cárie dentária.
- (B) Hipoplasia de esmalte.
- (C) Fluorose dentária.
- (D) Gengivite ulcerativa.
- (E) Periodontite agressiva.

Resposta: C

Comentário:

A fluorose dentária ocorre devido à ingestão excessiva de flúor durante a formação dos dentes, levando a alterações no esmalte que se manifestam como manchas brancas, opacas ou até manchas mais severas. É um efeito colateral da exposição prolongada e excessiva ao flúor, especialmente quando há fontes múltiplas de fluoreto.

Mais detalhes podem ser vistos na nossa aula de Dentística: Cariologia e Flúor

FLUOROSE

Resultado da ingestão crônica de flúor durante o desenvolvimento dental que se manifesta como mudanças visíveis de opacidade do esmalte devido a alterações no processo de mineralização.

O grau dessas alterações é função direta da dose de F à que a criança está sujeita (mg F/kg/dia) e do tempo de duração da dose. Para causar uma alteração clínica visível de fluorose, a dose deve ser entre 0,05 e 0,07 mgF/dia/kg de peso corporal.

Como se trata de um efeito sistêmico, as alterações distribuem-se simetricamente dentro da boca, afetando os dentes em formação no período de ingestão de flúor.

Os aspectos clínicos da fluorose dentária são caracterizados por um espectro de mudanças que vão desde linhas opacas brancas finas cruzando transversalmente o longo eixo da coroa do dente até quadros onde áreas do esmalte gravemente hipomineralizadas se rompem e, geralmente, o esmalte restante fica pigmentado.

A **fluorose dentária leve** causa apenas alterações estéticas, caracterizadas por pigmentação branca no esmalte dentário.

Questão 35:

Traumatismos dentários (TD) representam um dos mais sérios problemas de saúde pública. A avulsão dentária é um dos tipos mais graves de TD e pode ser definida como o completo deslocamento do dente para fora do seu alvéolo. A adoção de um rápido e adequado atendimento no local do acidente representa fator importante para obtenção de um prognóstico favorável. Assinale a alternativa que apresente corretamente os procedimentos indicados para o atendimento imediato:

- (A) O dente avulsionado deve ser lavado vigorosamente com água corrente e sabão ou álcool antes de ser segurado pela raiz e reposicionado na cavidade bucal.
- (B) A forma correta de segurar o dente avulsionado é pela raiz, garantindo o contato direto com a porção mais próxima do ligamento periodontal para facilitar o reimplante.
- (C) Ao encontrar o dente avulsionado, deve-se evitar tocá-lo e encaminhar o paciente imediatamente ao consultório, sem qualquer tentativa de reimplante no local do acidente.
- (D) Recomenda-se segurar o dente avulsionado pela coroa, na presença de sujidades lavá-lo com leite, soro fisiológico ou saliva do próprio paciente, e recolocá-lo imediatamente na arcada dentária.
- (E) A orientação principal em casos de avulsão dentária é conservar o dente seco, embalado em um papel limpo, e levá-lo ao atendimento odontológico em até 48 horas.

Resposta: D

Comentário:

Os procedimentos indicados para o atendimento imediato de um dente avulsionado são:

- Segurar o dente pela coroa, evitando tocar na raiz para prevenir danos às fibras do ligamento periodontal.
- Se o dente estiver sujo, lavar rapidamente com leite, soro fisiológico ou saliva do próprio paciente.

- Reposicionar o dente imediatamente no alvéolo, se possível.
- Caso não seja possível o reimplante imediato, conservar o dente em meio úmido adequado, como leite ou solução salina, e encaminhar o paciente imediatamente para atendimento odontológico.

Mais detalhes podem ser vistos na aula de Odontopediatria: Traumatologia em Odontopediatria

- **Avulsão dental:**
- É o deslocamento total ou a desarticulação completa do dente traumatizado de seu alvéolo
- O tratamento indicado para dentes **permanentes** é o reimplante dentário imediato, podendo ser realizado por qualquer pessoa nos primeiros 10 min após o acidente.
- No entanto, passado mais tempo, alguns fatores devem ser analisados anteriormente com intuito de verificar sua viabilidade
- **Período extra-alveolar:**
- O tempo crítico de reposição do dente no alvéolo foi estabelecido em torno de **15 min** após a sua avulsão
- Quando o reimplante for realizado dentro desse período, as chances de permanência do dente no alvéolo, sem reabsorção radicular externa, são de aproximadamente 90%;
- Após **30 min**, cai para 70%;
- Após **60 min**, para apenas 25%.
- **Meio de estocagem:**
- Caso o dente avulsionado não possa ser reimplantado de imediato, deve ser mantido em ambiente úmido
- Acredita-se que o leite, por ser um meio isotônico, com pH ligeiramente alcalino e relativamente sem bactérias, é um excelente meio de estocagem, mesmo quando comparado com água de torneira, soro fisiológico ou saliva.
- Cabe lembrar que o melhor meio é o próprio alvéolo, pois o ideal é que o paciente chegue ao atendimento odontológico em 15 a 30 min para manter a viabilidade periodontal, o que é muito difícil.
- **Procedimentos clínicos para o reimplante de dentes permanentes:**
- O dente deve ser reimplantado o mais rapidamente possível, de preferência em um intervalo de 15 a 30 min.
- O dente deve ser colocado de imediato no alvéolo pelo próprio indivíduo ou seu responsável, após cuidados mínimos de higiene, como lavagem em água corrente ou soro fisiológico, quando possível.
- Feito o reimplante, o dente deve ser mantido em posição por leve pressão digital ou por meio de uma gaze dobrada, que o indivíduo deve morder até a sua chegada ao consultório.
- No ato do reimplante, o dente deve ser colocado com movimentos suaves no alvéolo e sob leve pressão.
- Com o auxílio de resina fotopolimerizável, pode-se fixar provisoriamente o dente avulsionado, pelas suas proximais, aos dentes vizinhos.
- Feito o reimplante, o dente deve ser mantido em posição e radiografado, observando-se uma adequada relação entre o dente e o alvéolo
- Estando o dente em sua posição correta, realiza-se a **contenção**, que deve ser flexível (fio de náilon) ou semirrígida e com duração mínima de 7 e máxima de 10 dias.
- O método que vem sendo sugerido atualmente é o da utilização da resina, com o fio de náilon, para dar certa mobilidade ao dente.
- Assim, decorrido o tempo de contenção, em casos de ápice fechado e tempo extra-alveolar superior a 10 min, passa-se a realizar o **tratamento endodôntico**.

Questão 36:

De acordo com a Lei Federal nº 8.142/1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos

financeiros na área da saúde, qual órgão é autorizado a estabelecer, por meio de portaria, as condições necessárias à aplicação da referida Lei nº 8.142/1990?

- (A) Ministério da Saúde.
- (B) Presidência da República.
- (C) Congresso Nacional.
- (D) Conselho Nacional de Saúde.
- (E) Tribunal de Contas da União.

Resposta: A

Comentário:

De acordo com a Lei Federal nº 8.142/1990, especificamente no artigo 5º, é o Ministério da Saúde, por meio do Ministro de Estado da Saúde, que está autorizado a estabelecer, mediante portaria, as condições necessárias para a aplicação da referida lei.

Lê-se: “Art. 5º É o Ministério da Saúde, mediante portaria do Ministro de Estado, autorizado a estabelecer condições para aplicação desta lei.”

Questão 37:

Em procedimentos de pequenas cirurgias odontológicas, o manejo da dor pós-operatória é um componente essencial para o bem-estar do paciente. Analise as alternativas abaixo e assinale a correta sobre as condutas recomendadas ao cirurgião-dentista em relação ao controle da dor após o procedimento:

- (A) O cirurgião-dentista deve evitar discutir sobre dor com o paciente antes da cirurgia, para não gerar ansiedade e expectativas negativas quanto ao procedimento.
- (B) Não é necessário orientar os pacientes sobre o uso de analgésicos, pois a maioria dos incômodos desaparece espontaneamente sem necessidade de medicação após cirurgia odontológica.
- (C) A orientação sobre o uso de analgésicos deve ocorrer somente após o aparecimento da dor, não sendo recomendada a orientação prévia sobre o uso de medicamentos.
- (D) O cirurgião-dentista deve orientar previamente o paciente sobre a dor esperada, prescrever analgesia adequada e esclarecer que o objetivo da medicação é o controle, e não a eliminação total do desconforto.
- (E) Não é necessário orientar todos os pacientes sobre o uso de analgésicos, sendo essa conduta reservada apenas aos casos de cirurgias de alto risco.

Resposta: D

Comentário:

- (A) Incorreto. A discussão prévia é fundamental. Esclarecer as expectativas de dor e o plano de manejo reduz a ansiedade, aumenta a confiança e permite que a medicação comece a agir antes do término da anestesia.
- (B) Incorreto. Embora incômodos leves possam desaparecer, cirurgias odontológicas geralmente causam dor que requer intervenção medicamentosa para o conforto do paciente. A orientação é obrigatória.
- (C) Incorreto. Esperar a dor se instalar antes de medicar é uma abordagem menos eficaz. A analgesia antes do procedimento ou o uso na primeira hora pós-operatória (antes do efeito da anestesia passar) é a conduta ideal para manter a dor sob controle.
- (D) Correto. Esta é a conduta completa e ideal: informação prévia (reduzindo ansiedade), prescrição adequada (garantindo que o paciente tenha o medicamento), e gerenciamento das expectativas (o objetivo é o controle, e não a ausência total de dor).
- (E) Incorreto. Todos os pacientes submetidos a qualquer tipo de cirurgia com potencial de dor pós-operatória devem receber orientação e prescrição adequada de analgesia.

Questão 38:

Durante uma reunião sobre direitos, um servidor do setor de Recursos Humanos questiona qual é o prazo legal previsto no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Varginha para a licença concedida à servidora gestante, garantindo manutenção do cargo, da remuneração e das férias. De acordo com o artigo 110 do Estatuto, o período dessa licença é de:

- (A) 90 dias consecutivos.
- (B) 180 dias consecutivos.
- (C) 60 dias consecutivos.
- (D) 100 dias consecutivos.
- (E) 210 dias consecutivos.

Resposta: B

Comentário:

De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Varginha, alterado pela Lei Municipal 5.025/2009, a licença-maternidade é concedida pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos.

A informação é corroborada por portarias municipais que citam o referido artigo e a Lei 5.025/2009, a qual estendeu o prazo constitucional de 120 dias para 180 dias.

Questão 39:

Considerando a vigilância em saúde bucal em comunidades vulneráveis, e levando em conta as ações de promoção da saúde, analise os itens abaixo e assinale a alternativa correta.

I. As ações de promoção da saúde objetivam reduzir as diferenças no estado de saúde da população e assegurar oportunidades e recursos igualitários para capacitar todas as pessoas a realizar completamente seu potencial de saúde.

II. Diversas circunstâncias podem influenciar a saúde bucal, desde características individuais ligadas a estilo de vida e consumo, até circunstâncias sociais, tais como características geográficas e socioeconômicas, acesso a recursos materiais e sociais.

III. O ambiente no qual as pessoas vivem, trabalham e estudam tem grande participação no desenvolvimento de doenças e também na manutenção da saúde. A boa condição do ar, da água e dos alimentos é crucial para uma vida saudável, cabendo, portanto, aos profissionais de saúde bucal, alertar os indivíduos sobre os cuidados a serem tomados com relação ao ambiente em que vivem.

(A) Apenas o item I está correto.

(B) Apenas os itens I e II estão corretos.

(C) Apenas os itens I e III estão corretos.

(D) Apenas o item II está correto.

(E) Todos os itens estão corretos.

Resposta: E

Comentário:

I. Correto. A promoção da saúde objetiva reduzir desigualdades no estado de saúde e assegurar recursos e oportunidades igualitárias para o desenvolvimento do potencial de saúde, conforme princípios da promoção da saúde baseada em equidade.

II. Correto. A saúde bucal é multifatorial e influenciada pelos Determinantes Sociais da Saúde (DSS). Isso inclui fatores proximais (estilo de vida, dieta, consumo) e fatores distais (condição socioeconômica, acesso a serviços, geografia e ambiente social).

III. Correto. Este item reconhece a influência do ambiente físico e social (água, ar, alimentos) na saúde geral e bucal, um pilar da Promoção da Saúde. A responsabilidade do profissional de saúde bucal, dentro da abordagem integral da Atenção Primária, é, de fato, alertar e articular ações com outros setores e membros da equipe (como o Agente Comunitário de Saúde) sobre os riscos ambientais que afetam a saúde da comunidade, extrapolando o olhar exclusivo para o dente.

Podemos ver mais detalhes na nossa aula de SUS e Saúde Pública: Política Nacional De Promoção Da Saúde

Princípios da PNPS:

- ✓ **Equidade** - distribuição igualitária de oportunidades, considerando as especificidades dos indivíduos e dos grupos;
 - ✓ **Participação Social** - quando as intervenções consideram a visão de diferentes atores, grupos e coletivos na identificação de problemas e solução de necessidades, atuando como corresponsáveis no processo de planejamento, de execução e de avaliação das ações;
 - ✓ **Autonomia** - se refere à identificação de potencialidades e ao desenvolvimento de capacidades, possibilitando escolhas conscientes de sujeitos e comunidades sobre suas ações e trajetórias;
 - ✓ **Empoderamento** - se refere ao processo de intervenção que estimula os sujeitos e coletivos a adquirirem o controle das decisões e das escolhas de modos de vida adequado às suas condições sócio-econômico-culturais;
 - ✓ **Intersetorialidade** - se refere ao processo de articulação de saberes, potencialidades e experiências de sujeitos, grupos e setores na construção de intervenções compartilhadas, estabelecendo vínculos, corresponsabilidade e cogestão para objetivos comuns;
 - ✓ **Intrasetorialidade** - diz respeito ao exercício permanente da desfragmentação das ações e serviços ofertados por um setor, visando à construção e articulação de redes cooperativas e resolutivas;
-
- ✓ **Sustentabilidade** - diz respeito à necessidade de permanência e continuidade de ações e intervenções, levando em conta as dimensões política, econômica, social, cultural e ambiental;
 - ✓ **Integralidade** - quando as intervenções são pautadas no reconhecimento da complexidade, potencialidade e singularidade de indivíduos, grupos e coletivos, construindo processos de trabalho articulados e integrais;
 - ✓ **Territorialidade** - diz respeito à atuação que considera as singularidades e especificidades dos diferentes territórios no planejamento e desenvolvimento de ações intra e intersetoriais com impacto na situação, nos condicionantes e nos determinantes da saúde neles inseridos, de forma equânime.

Questão 40:

Leia o enunciado abaixo com atenção e assinale a alternativa que apresenta corretamente a sequência, considerando V (Verdadeiro) ou F (Falso):

A Microbiologia Bucal estuda os microrganismos presentes na nossa boca. Esses organismos são:

- () Vírus;
 - () Fungos;
 - () Bactérias.
- (A) V, V, V.
(B) F, V, F.
(C) V, V, F.
(D) F, F, V.
(E) Nenhuma das alternativas.

Resposta: A**Comentário:**

A Microbiologia Bucal estuda os microrganismos presentes na boca, que compreendem vírus, fungos e bactérias, todos com presença confirmada no ambiente oral. Esses grupos microbianos desempenham papéis variados, desde a manutenção da saúde até a etiologia de doenças bucais.

Mais detalhes podem ser vistos na nossa aula de Periodontia: Microbiologia e Etiopatogenia das Doenças Periodontais

Existem 3 principais entidades microbianas: bactérias, vírus e fungos, sendo os vírus menores que as bactérias, que são menores que os fungos.

Bactérias	Vírus	Fungos
Procarióticos (sem membrana nuclear)	Acelulares (capa proteica com material genético)	Eucarióticos (possuem membrana nuclear)
Unicelulares	Bacteriófagos: combinam o material genético com as bactérias	Cogumelos (macroscópicos e multicelulares)
Reprodução por divisão binária	Bacteriolíticos: causam lise nas bactérias	Bolores (filamentosos e microscópicos – multicelulares)
		Leveduras (esferoides e microscópicos – unicelulares)

Questão 41:

Analise os itens abaixo sobre exodontia simples e assinale a alternativa correta.

I. Para melhor visibilidade e acesso nas exodontias mandibulares, a mandíbula do paciente deve estar paralela ao chão e deve estar no nível do cotovelo do cirurgião.

II. Para realizar exodontia simples, o processo envolve o uso de força controlada para expandir os alvéolos, separar o ligamento periodontal e remover o dente. Alguns fatores determinantes para o sucesso de uma exodontia simples incluem um bom conhecimento da anatomia oral e dental, a compreensão das técnicas cirúrgicas utilizadas e, acima de tudo, a experiência cirúrgica.

III. A extração dos dentes anteriores da maxila deve ser realizada preferencialmente por palatino, uma vez que o osso palatino possui menor densidade e permite maior expansão do alvéolo, além disso, os movimentos rotacionais são contraindicados em dentes com raízes cônicas, pois aumentam a resistência do ligamento periodontal e dificultam a remoção do dente.

- (A) Apenas o item I está correto.
(B) Apenas os itens I e II estão corretos.
(C) Apenas os itens I e III estão corretos.
(D) Apenas o item II está correto.
(E) Todos os itens estão corretos.

Resposta: B**Comentário:**

I. Correto. O posicionamento ideal para a mandíbula (arcada inferior) é que o plano oclusal esteja paralelo ao chão (ou ligeiramente abaixo do paralelo). A altura da cadeira deve ser ajustada para que a boca do paciente esteja na altura do cotovelo do cirurgião, permitindo o uso ergonômico e eficaz da força controlada do braço e do corpo.

II. Correto. A exodontia simples é a remoção de um dente erupcionado usando fórceps e elevadores, e o processo visa a separação das fibras do ligamento periodontal, a expansão óssea alveolar (pela cunha e alavanca) e a remoção final. O sucesso depende, de fato, do conhecimento da anatomia, da técnica e da experiência do operador.

III. Incorreto. Os dentes anteriores da maxila (incisivos e caninos) são extraídos com maior ênfase na tábua óssea vestibular, pois o osso vestibular é geralmente mais fino e mais facilmente expansível que o osso palatino. Movimentos rotacionais são altamente indicados em dentes com raiz cônica e única (como incisivos centrais e laterais superiores) para promover a lise do ligamento periodontal. São contraindicados em dentes com raízes curvas ou múltiplas.

Mais detalhes podem ser vistos na aula de Periodontia: Terapia não-cirúrgica e também na aula de Biossegurança: Ergonomia

TERAPIA NÃO-
CIRÚRGICA

Prof.ª Msc. Nathalya
Vilela



Posicionamento para uma Correta Acessibilidade (Ergonomia)

- O posicionamento adequado tanto do profissional como do paciente, favorecendo as noções de ergonomia, proporciona:
 - instrumentação completa
 - prevenção de lesões
 - prevenção do cansaço prematuro
 - prevenção da redução na eficiência do tratamento.



TERAPIA NÃO-
CIRÚRGICA

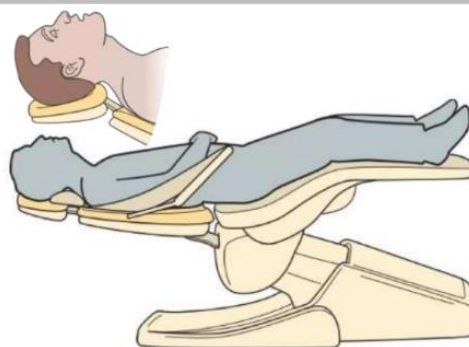
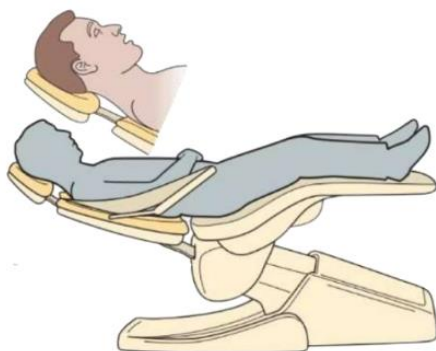
Prof.ª Msc. Nathalya
Vilela



Posicionamento para uma Correta Acessibilidade (Ergonomia)

Posicionamento do Paciente

- **Avaliação do arco superior**
 - encosto da cadeira posicionado a 180 graus
 - elevar a mandíbula



- **Avaliação do arco inferior**
 - encosto da cadeira posicionado a 120 graus
 - abaixar a mandíbula

Questão 42:

O abscesso periapical agudo é uma condição dolorosa que requer intervenção rápida para controle da infecção e alívio dos sintomas. Dentre as condutas adequadas para o seu tratamento, assinale a alternativa correta:

- Apenas prescrever antibióticos e aguardar regressão espontânea do abscesso.
- Realizar pulpectomia, esvaziamento e saneamento dos condutos radiculares, drenagem intra e/ou extrabucal do abscesso, curativo endodôntico e restauração provisória.
- Limitar-se à drenagem extrabucal, sem necessidade de tratamento endodôntico.
- Indicar extração imediata do dente em todos os casos, sem tentativa de tratamento conservador.
- Realizar apenas bochechos com soluções antissépticas até que o abscesso desapareça.

Resposta: B

Comentário:

- Incorreto. O tratamento da infecção endodôntica deve ser mecânico (remoção do tecido necrótico

e microrganismos do canal). O antibiótico é apenas um coadjuvante e não resolve a causa-raiz (a necrose pulpar e a infecção nos canais).

(B) Correto. Esta conduta abrange todas as etapas essenciais do tratamento:

- Abertura Coronária e Pulpectomia: Cria acesso para remover o tecido necrótico e o pus.
- Esvaziamento e Saneamento dos Condutos: Remove a fonte da infecção (microrganismos e seus subprodutos).
- Drenagem (Intra ou Extrabucal): Essencial para o alívio imediato da dor e redução da pressão.
- Curativo Endodôntico e Restauração Provisória: Medicação e vedamento temporário do acesso.

(C) Incorreto. A drenagem alivia o sintoma, mas não elimina a infecção presente nos canais radiculares, o que levaria à recidiva do abscesso.

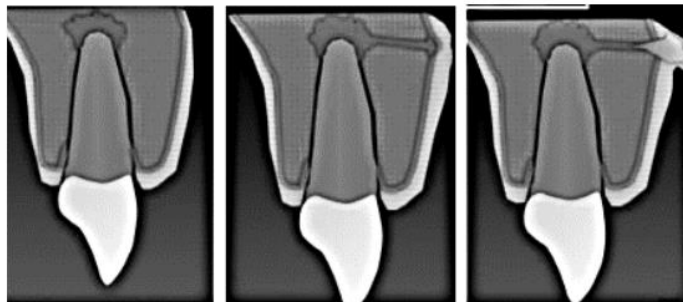
(D) Incorreto. A extração é o último recurso. O tratamento endodôntico (conservador) deve ser a primeira opção, pois visa manter o dente na arcada.

(E) Incorreto. O abscesso requer intervenção mecânica (acesso e drenagem) e endodôntica. Bochechos são ineficazes para tratar uma infecção que se encontra dentro do dente e no osso periapical.

Mais informações podem ser acessadas na nossa aula de Endodontia: Alterações Periapicais

➤ **ABSCESSE APICAL AGUDO:**

- Acúmulo de pus composto por macrófagos e polimorfonucleares;
- Dor espontânea, pulsátil, localizada com tumefação intra e extraoral em casos mais evoluídos;
- Pode estar associado à presença de edema e também causar mobilidade dentária;
- Pode ou não apresentar envolvimento sistêmico;
- O tratamento é drenagem e eliminação do agente agressor;
- Se não tratado pode evoluir para celulite, empiema e osteomielite;
- Patologia endodôntica comum no atendimento endodôntico emergencial;
- Histologicamente, essa lesão é destrutiva, localizada, de necrose liquefativa, que destrói os tecidos periapicais.



- 1) Fase intraóssea (inicial): dor pulsátil, mobilidade, vermelhidão. Drenagem via canal - Analgésivos, antibióticos e necropulpectomia. Nessa fase, a coleção purulenta ainda se localiza aprisionado no interior do tecido ósseo.
- 2) Fase subperiosteal (em evolução): dor difusa, edema, flegmão. Analgésicos, antibióticos e necropulpectomia. Nessa fase, a coleção purulenta rompe a barreira óssea e está em direção ao meio externo, sem ter rompido a barreira do periosteio.
- 3) Fase submucosa (evoluído): Fístula. Quando o pus se encontra abaixo apenas do tecido submucoso, podendo ser de aspecto difuso ou localizado.

- Antibioticoterapia, em casos em que o indivíduo apresente manifestações, como trismo, taquicardia, mal-estar, e febre que evidenciem que o sistema imunológico não está sendo capaz de combater a infecção sozinho, sendo necessário a eleição de um antibiótico de acordo com o padrão microbiológico presente na infecção (SANTOS, 2020)

Questão 43:

A gestação é um estado fisiológico que provoca alterações orgânicas, especialmente hormonais, como o aumento de estrogênio e progesterona, resultando na queda do pH salivar. Essas mudanças podem causar náuseas, vômitos, dificultar a escovação, alterar a saliva e aumentar o sangramento gengival.

É uma fase que exige cuidados com a saúde geral e bucal, pois infecções, inclusive as da boca, podem comprometer a gestação.

Analisar as alternativas abaixo e assinalar a correta sobre a **periodontite**:

- (A) A periodontite é a inflamação da gengiva, fazendo com que ela fique inchada, dolorida, podendo sangrar ao escovar os dentes ou até mesmo ao passar o fio dental, e pode ser causada pelo acúmulo de placa bacteriana.
- (B) A periodontite ocorre quando a placa bacteriana não é removida totalmente (por falta de higienização adequada), ela se torna endurecida e com aspecto amarelado.
- (C) A principal característica da periodontite gestacional é o acúmulo de placa bacteriana sem inflamação gengival, causando apenas alterações estéticas, como escurecimento da gengiva, sem riscos funcionais à dentição.
- (D) A periodontite é a evolução da inflamação da gengiva aos tecidos de suporte do dente. É quando a gengiva se afasta do dente e a inflamação atinge o osso ao qual o dente está ligado, podendo gerar sangramento, pus, odor, sensibilidade, mobilidade, após mobilidade, mau hálito e até possível perda dentária.
- (E) A periodontite ocorre quando surgem buracos nos dentes (cavidades) ocasionados pela incorreta remoção da placa dentária durante a escovação e a continuidade de alimentação rica em açúcares.

Resposta: D

Comentário:

- a) Incorreto. Esta é a definição de Gengivite, que é a inflamação limitada ao tecido gengival. A periodontite é a forma mais avançada, que envolve a perda dos tecidos de sustentação do dente.
- b) Incorreto. A placa bacteriana endurecida e com aspecto amarelado é o cálculo ou tártaro. O cálculo é um fator secundário, mas não a doença em si.
- c) Incorreto. A periodontite sempre envolve inflamação e a perda dos tecidos de suporte (osso alveolar, cemento radicular e ligamento periodontal).
- d) Correto. Esta é a definição precisa de Periodontite. Ela é caracterizada pela inflamação que se estende ao cemento, ligamento periodontal e osso alveolar, levando à formação de bolsas periodontais, perda de inserção, mobilidade e, em casos avançados, à perda do dente.
- e) Incorreto. Esta é a definição da cárie dentária, uma doença de tecido duro. A periodontite é uma doença de tecido mole (gengiva) e de suporte.

Mais detalhes podem ser vistos na aula de Periodontia: Exames Periodontais e na aula Relação das Doenças Periodontais com as Condições Sistêmicas

EXAMES PERIODONTAIS
Prof.ª Msc. Nathalya Vilela



- O acúmulo de biofilme leva à inflamação gengival (gengivite) que, caso não tratada, pode “evoluir” para a periodontite
- Equilíbrio “saúde x doença” → ataque microbiano x resposta imune
 - condições ambientais, sistêmicas, genéticas...
- **Simbiose**: interação entre microrganismos levando à saúde
- **Disbiose**: interação entre microrganismos levando à doença

Biofilme: fator etiológico primário da gengivite, mas fator de RISCO da periodontite!



DOENÇAS PERIODONTAIS E CONDIÇÕES
SISTÊMICAS

Prof.ª Msc. Nathalya
Vilela



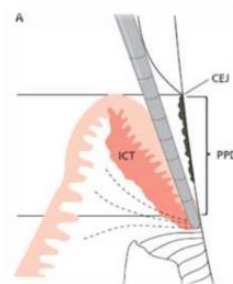
- A **Periodontite** é caracterizada pela destruição das estruturas de suporte dos dentes (ligamento periodontal, osso alveolar e cemento radicular)

A gravidade da doença vai depender da interação entre o agente causador e a resposta imunoinflamatória do hospedeiro!



Acaba interferindo na resposta imunoinflamatória do organismo

- As **doenças crônicas** são doenças que, ao afetar os órgãos-alvo, acabam afetando o organismo como um todo.
 - A exemplo dessas doenças temos doenças cardiovasculares, diabetes, doença respiratória crônica, câncer, Alzheimer, osteoporose, obesidade, entre outras.



Questão 44:

Julgue os itens abaixo sobre a placa bacteriana (biofilme dental) e assinale a alternativa correta.

I - As placas bacterianas são lesões na forma de bolhas, manchas, nódulos e úlceras, formada por bactérias e restos alimentares acumulados na superfície dos dentes e na gengiva.

II - A placa bacteriana se desenvolve mais rápido com a ingestão frequente de açúcares. Se não for removida, pode causar cáries, cálculo dentário, doenças da gengiva e mau hálito.

A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.

As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é um complemento da I.

A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.

As asserções I e II são proposições falsas.

As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é um complemento da I.

Resposta: A

Comentário:

I. Incorreto. A placa bacteriana (biofilme dental) não é uma lesão na forma de bolhas, manchas, nódulos ou úlceras. A placa bacteriana é uma película pegajosa e incolor formada por uma agregação complexa de microrganismos e restos alimentares que se acumulam sobre a superfície dos dentes e gengiva, e não uma lesão visível como as descritas.

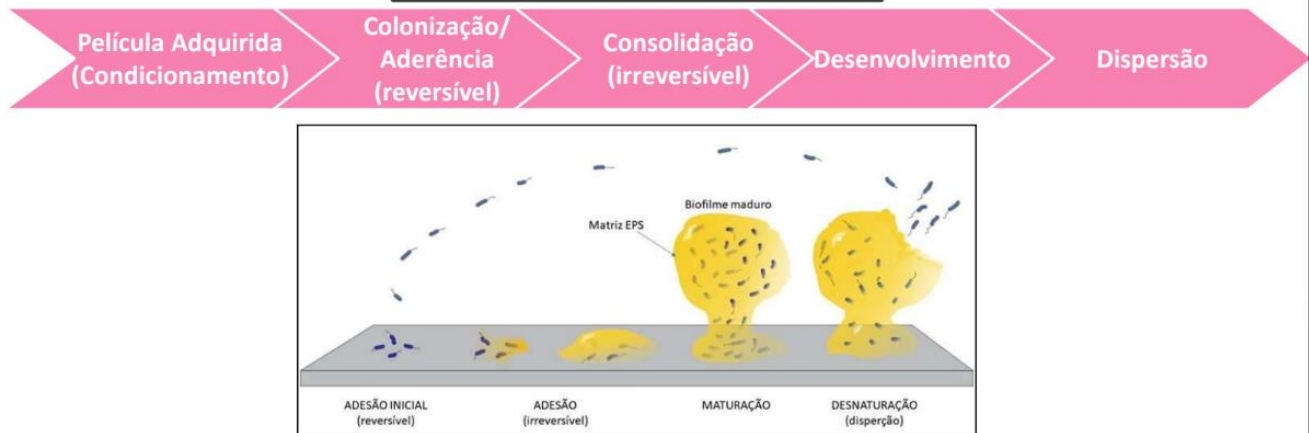
II. Correto. A placa bacteriana se desenvolve mais rapidamente com a ingestão frequente de açúcares, pois as bactérias utilizam esses açúcares para produzir ácidos que danificam o esmalte dentário e facilitam a mineralização da placa em cálculo dentário. Se não removida, pode causar cáries, doenças gengivais (como gengivite e periodontite) e mau hálito.

Mais detalhes podem ser vistos na nossa aula de Periodontia: Microbiologia e Etiopatogenia das Doenças Periodontais

Biofilme dentário

Biofilme dentário → conjunto de microrganismos envolvidos em uma matriz biopolimérica extracelular (proteínas, polissacarídeos, material genético) que se encontra aderida a uma superfície sólida (dente)

Mecanismo de formação do Biofilme



Questão 45:

Analise as alternativas abaixo e assinale a correta sobre a **classificação dos fatores** causadores da doença periodontal.

- (A) Os fatores são classificados em: determinantes, predisponentes, modificadores e iatrogênicos.
- (B) Os fatores são classificados em: mecânicos, iatrogênicos, bacterianos e genéticos.
- (C) Os fatores são classificados em: Gram-negativos facultativos anaeróbios, sistêmicos, psicossomáticos e infecciosos.
- (D) Os fatores são classificados em: agentes infecciosos, imunológicos, ambientais e traumáticos.
- (E) Os fatores são classificados em: sociais, predisponentes, psicológicos e microbiológicos.

Resposta: A

Comentário:

De acordo com a Nova Classificação das Doenças e Condições Periodontais e Perimplantares, os fatores que influenciam no estabelecimento das doenças periodontais são:

- **Fatores de risco sistêmico (também conhecidos como “Fatores Modificadores”):** Tabagismo, Distúrbios metabólicos (ex: hiperglicemia), Fatores nutricionais, Agentes farmacológicos (prescritos, não prescritos e recreativos), Hormônios (sexuais esteroidais, puberdade, ciclo menstrual, gestação, contraceptivos orais), Condições hematológicas (ex: leucemia, anemia, hemofilia...)
- **Fatores de risco locais (também conhecidos como “Fatores Predisponentes”):** Fatores retentores de biofilme (ex: restaurações iatrogênicas), Secura bucal, Fraturas, Anatomia dental (ex: pérolas de esmalte, projeções cervicais do esmalte...)

A alternativa A sugere corretamente os fatores predisponentes e os modificadores, porém, “fatores iatrogênicos” entram na categoria dos fatores predisponentes e “fatores determinantes” não estão inclusos nos documentos oficiais da Nova Classificação, mas podem ser considerados, tendo em vista que o acúmulo de biofilme é o principal fator etiológico da inflamação periodontal.

Essas observações podem ser vistas em documentos traduzidos, como a Revista de Odontologia da UNESP, publicada na Scielo:

<https://www.scielo.br/j/rounesp/a/F9F6gnVnNm6hFt6MBrJ6dHC/?format=pdf&lang=pt>

**B. GENGIVITE MEDIADA POR FATORES DE RISCO
SISTÊMICOS OU LOCAIS**

- Fatores de risco sistêmicos (fatores modificadores)
 - (a) Tabagismo
 - (b) Hiperglicemia
 - (c) Fatores nutricionais
 - (d) Agentes farmacológicos (prescritos, não prescritos e recreacionais)
 - (e) Hormônios esteroides sexuais (*puberdade, ciclo menstrual, gravidez e contraceptivos orais*)
 - (f) Condições hematológicas
- Fatores de risco locais (fatores predisponentes)
 - (a) Fatores de retenção de biofilme dental (*por exemplo, margens de restaurações proeminentes*)
 - (b) Secura bucal

Questão 46:

A saúde de uma população, em especial a saúde bucal, é expressa claramente pelas condições do meio no qual ela está inserida e, principalmente, pela forma com que são estabelecidos os relacionamentos interpessoais e familiares. A primeira infância é o período ideal para introduzir bons hábitos e iniciar um programa educativo/preventivo de saúde bucal.

Sobre a **dentição mista**, é correto afirmar:

- (A) A dentição mista tem início com a esfoliação dos incisivos centrais decíduos e é caracterizada por alterações mínimas na oclusão, encerrando-se com a completa erupção dos caninos permanentes superiores e inferiores, o que estabelece o segundo período de levantamento fisiológico da mordida.
- (B) A dentição mista tem início com a esfoliação dos primeiros molares decíduos e é marcada pelo desenvolvimento dos dentes posteriores permanentes, encerrando-se com a erupção dos terceiros molares, o que determina a finalização do alinhamento oclusal funcional.
- (C) A dentição mista tem início com a erupção dos primeiros molares permanentes, quando se dá o primeiro período de levantamento fisiológico da mordida. Posteriormente, outros dois períodos desse levantamento ocorrem pela erupção dos segundos e terceiros molares consecutivamente.
- (D) O início da dentição mista coincide com a perda dos caninos decíduos e é acompanhada por alterações sutis na morfologia facial, encerrando-se com a esfoliação dos incisivos permanentes superiores, quando já está estabelecida a oclusão estável e definitiva da arcada dentária.
- (E) O início da dentição mista é delimitado pelo surgimento dos incisivos laterais permanentes e termina com a erupção dos segundos molares decíduos, sendo considerado um estágio clínico sem influência relevante sobre o posicionamento oclusal futuro.

Resposta: C**Comentário:**

O início com a erupção dos primeiros molares permanentes e a ocorrência do primeiro levantamento fisiológico da mordida são marcos corretos desta fase. Os levantamentos subsequentes são marcados pela erupção dos segundos e terceiros molares (embora este último já seja na dentição permanente). A descrição abrange os marcos principais da fase de transição.

Mais informações podem ser vistas na nossa aula de Odontopediatria: Odontogênese e Irrupção

DENTIÇÃO MISTA**Coexistência de dentes permanentes e decíduos**

Ocorrência de uma série de alterações dimensionais, morfológicas e estruturais.

- DENTIÇÃO MISTA INICIAL (PRIMEIRO PERÍODO TRANSICIONAL): Incisivos decíduos em esfoliação e irrupção dos incisivos e molares permanentes;
- DENTIÇÃO MISTA INTERMEDIÁRIA (PERÍODO INTERTRANSICIONAL): Incisivos e molares permanentes totalmente irrompidos, caninos e molares decíduos presentes;
- DENTIÇÃO MISTA FINAL (SEGUNDO PERÍODO TRANSICIONAL): Esfoliação dos caninos e molares decíduos, irrupção de caninos permanentes e pré-molares

Questão 47:

Pessoas em situação de rua frequentemente enfrentam o uso abusivo de substâncias psicoativas, como o álcool e drogas ilícitas, que, somadas à negligência na higiene oral e às condições sociais adversas, provocam graves consequências para a saúde bucal. Analise as alternativas a seguir e assinale a correta sobre as principais alterações periodontais relacionadas ao **uso abusivo do álcool**.

(A) O consumo excessivo de álcool está associado principalmente à gengivite hipertrófica, aumento do fluxo salivar e regeneração óssea alveolar, sem prejuízo para a recessão gengival.

(B) O uso abusivo do álcool provoca necrose e perfuração do septo nasal. Esse efeito vasoconstrictor produz irritação da mucosa do palato, que pode evoluir para perfuração nasal e destruição dos ossos maxilares.

(C) As principais alterações periodontais relacionadas ao abuso do álcool são gengivite ulceronecrosante, periodontite, recessão gengival, além de maior quantidade de perda do osso alveolar e diminuição do fluxo salivar.

(D) O álcool atua como protetor da mucosa oral, prevenindo a perda óssea alveolar e favorecendo a cicatrização dos tecidos periodontais sem comprometimento gengival.

(E) Entre as principais alterações periodontais relacionadas ao abuso do álcool encontram-se cárie dentária, doenças periodontais, leucoplasia, estomatite canábica, xerostomia, bruxismo e candidose.

Resposta: C**Comentário:**

O uso crônico de álcool provoca diversas alterações deletérias na saúde bucal, incluindo a gengivite necrosante (devido à imunossupressão e má nutrição), que é caracterizada por ulcerações, dor e sangramento gengival.

Está associado à progressão para periodontite (devido ao comprometimento da resposta imune), com inflamação crônica do periodonto, recessão gengival e perda óssea alveolar significativa.

O álcool também causa redução do fluxo salivar (devido aos efeitos diuréticos e desidratantes do álcool), contribuindo para maior colonização bacteriana e agravamento das doenças periodontais.

Essas alterações são decorrentes do efeito tóxico do álcool nos tecidos periodontais, na resposta imunológica e na microbiota bucal, tornando o indivíduo mais suscetível a infecções e comprometendo a regeneração tecidual.

Questão 48:

As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS) obedecem aos seguintes princípios, EXCETO o que se apresenta em:

(A) Participação da comunidade.

(B) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.

(C) Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde.

(D) Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário.

(E) Organização dos serviços públicos de modo a acolher a triplicidade de meios para fins idênticos.

Resposta: E**Comentário:**

De acordo com a Lei 8080 de 1999, dos Princípios e Diretrizes do SUS, lê-se:

“XIII - organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos”.

Para mais detalhes, ver a nossa aula de SUS e Saúde Pública: Lei 8080 De 19 de Setembro de 1990

VII - utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática;

VIII - participação da comunidade;

IX - descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo:

a) ênfase na descentralização dos serviços para os municípios;

b) regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde;

X - integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico;

XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população;

XII - capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência;

XIII - organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos;

XIV – organização de atendimento público específico e especializado para mulheres e vítimas de violência doméstica em geral, que garanta, entre outros, atendimento, acompanhamento psicológico e cirurgias plásticas reparadoras, em conformidade com a Lei nº 12.845, de 1º de agosto de 2013.

Questão 49:

As urgências em odontologia estão intimamente associadas aos casos clínicos relacionados à sintomatologia dolorosa e/ou ao edema inflamatório/infeccioso de etiologia odontogênica e não odontogênica.

Analisar os itens a seguir e assinalar a alternativa correta sobre profilaxia antibiótica e antibioticoterapia nas urgências odontológicas:

I. A profilaxia consiste na administração de antimicrobianos pré ou pós-intervenção para prevenir a proliferação e disseminação de bactérias.

II. O uso de antimicrobianos nas urgências odontológicas tem como objetivo promover a colonização de bactérias em pacientes isentos de infecção (profilaxia antibiótica) ou atuar como agente principal no tratamento dos quadros infecciosos agudos (antibioticoterapia).

(A) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.

(B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é um complemento da I.

(C) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.

(D) As asserções I e II são proposições falsas.

(E) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é um complemento da I.

Resposta: C**Comentário:**

I. Incorreto. A profilaxia antibiótica é a administração de antimicrobianos em pacientes sem infecção ativa, com o objetivo de prevenir a ocorrência de uma infecção, seja ela no sítio cirúrgico ou à distância, após um procedimento invasivo. Porém, o preconizado é que seja uma administração “pré-procedimento”, como indica a American Heart Association.

Fonte: <https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIR.0000000000000969>

II. Falso. O objetivo da profilaxia antibiótica não é promover a colonização de bactérias; pelo contrário, é prevenir a colonização e a infecção. Na antibioticoterapia, o uso de antimicrobianos atua como um agente de combate, mas o agente principal no tratamento de infecções, é a intervenção odontológica em si (drenagem, eliminação da causa no canal radicular ou extração), sendo o antibiótico um coadjuvante.

Questão 50:

Em atendimentos Odontológicos, a equipe encontra-se continuamente exposta ao risco de transmissão, tanto direta quanto indireta, de doenças infectocontagiosas, como hepatite, HIV, herpes, tuberculose, entre outras. À luz das medidas de biossegurança e dos diferentes modos de transmissão, analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta, considerando V (Verdadeiro) ou F (Falso):

- () A transmissão por via aérea, também denominada infecção por gotículas, consiste na propagação de doenças por meio de gotículas de umidade expelidas, as quais podem conter microrganismos como bactérias ou vírus.
- () A transmissão indireta ocorre quando os microrganismos são transmitidos inicialmente a objetos ou superfícies e em seguida transferidos para outra pessoa que toca esses objetos e superfícies.
- () O sangue presente na saliva, quando não visível, deve ser desconsiderado como risco, visto que sua concentração geralmente não é suficiente para transmitir doenças infectocontagiosas.
- (A) V, F, V.
(B) F, V, F.
(C) V, V, F.
(D) F, F, V.
(E) Nenhuma das alternativas.

Resposta: C

Comentário:

1. A transmissão por via aérea ou por gotículas é a propagação de doenças por meio de gotículas de umidade contendo microrganismos (bactérias, vírus) expelidas pelo paciente. Isso é verdadeiro e é uma das formas comuns de transmissão no ambiente odontológico.
2. A transmissão indireta ocorre quando microrganismos presentes em objetos ou superfícies contaminadas são transferidos para outra pessoa por contato, o que também é verdadeiro e um risco importante em odontologia.
3. A afirmativa de que sangue presente na saliva, quando não visível, deve ser desconsiderado como risco é falsa. O sangue pode estar presente em concentrações extremamente baixas, mas ainda assim representam risco significativo para a transmissão de doenças infectocontagiosas (como hepatite B, HIV). Por isso, qualquer contato com saliva com possível sangue oculto é considerado de risco e requer medidas rigorosas de biossegurança.

Mais detalhes podem ser vistos na nossa aula de Biossegurança: NR 32 e na aula: Doenças, Esquema de Vacinação e Conduta Pós Acidente

Vias de transmissão: percurso feito pelo agente biológico a partir da fonte de exposição até o hospedeiro. A transmissão pode ocorrer das seguintes formas:

1. Direta: transmissão do agente biológico, sem a intermediação de veículos ou vetores.
2. Indireta: transmissão do agente biológico por meio de veículos ou vetores.

Transmissão Direta - Ocorre por meio de contato de **pessoa a pessoa**. Doenças como hepatite, infecção por herpes, infecção pelo HIV e tuberculose são disseminadas por contato direto que podem ser via aérea (gotículas que se espalham através de tosse ou espirros, por exemplo) e também via contato sem proteção como sangue, saliva, sêmen e secreções vaginais. A **exposição ao sangue** é um assunto muito importante e preocupação especial para a equipe odontológica durante o tratamento odontológico. Embora o sangue não possa ser visto na saliva, frequentemente está presente.

Transmissão Indireta - Ocorre quando os microrganismos são transmitidos **inicialmente a objetos ou superfícies e em seguida para outra pessoa que toca esses objetos e superfícies**. Essa situação não é incomum e um exemplo corriqueiro é quando um membro da equipe odontológica manuseia uma ficha clínica com luvas e logo após essa mesma ficha é manuseada pela secretária sem luvas. É importante higienizar as mãos com frequência e desinfetar frequentemente e cuidadosamente bem como cobrir as superfícies que podem ser contaminadas para evitar a transmissão indireta de microrganismos **também conhecida com infecção cruzada**

Transmissão por Via Aérea - Também conhecida como infecção por gotículas, trata-se da **propagação de doenças através de gotículas ou aerossóis de umidade que contém bactérias ou vírus**. A maior parte das doenças respiratórias contagiosas é causada por patógenos que são transportados em gotículas de umidade. Alguns deles são transportados por longas distâncias através do ar e sistemas de ventilação. É uma transmissão que pode ocorrer também através de tosse ou espirro.